Panel N°4

Thème: Qualité des soins et services de santé en santé maternelle et infantile

Direction de la qualité des soins et de la sécurité des patients,

Ministère de la santé

Bobo Dioulasso, 25 Juillet 2025

Plan

- Introduction
- Situation de la qualité des soins et services en SMI
- Outils et bonnes pratiques de renforcement de la qualité des soins et services en SMI
- Défis
- Recommandations & perspectives
- Conclusion

Introduction

- Taux de mortalité maternelle et néonatale demeurent élevés dans le monde malgré les efforts consentis par les Etats;
- OMS déplore 800 décès maternels et 7 700 décès néonatals quotidiens évitables
- Défis similaires au BF; mortalité maternelle persistante malgré l'augmentation du taux d'accouchements → Nécessité de renforcer la qualité des soins et de services de SMI.

Situation de la qualité des soins et services en SMI

- Données extraites de la plateforme e-qualité (référentiel qualité des FS du BF)

- Echantillon : **148 FS publiques et privées**

  - 49 CMA (audit diagnostic, 2022)
  - 05 CHU, 01 CHUR et 02 hôpitaux privés (audit de certification, 2022)
  - 09 CHR et 06 polycliniques (audit de certification, 2022)
  - 76 cliniques/CMC (audit diagnostic, 2022)

Situation de la qualité des soins et services en SMI

Plusieurs variables en lien avec les critères suivants:

- Qualité de l'organisation globale des services de maternité
- Qualité des SPN
- Qualité de la PEC de l'accouchement
- Qualité de la PEC immédiate du nouveau-né
- Qualité de la PF

Situation de la qualité des soins et services en SMI

❑Qualité de l'organisation globale des services de maternité (N=24)

Items	24 FS dont 5 CHU, 1 CHUR, 3 HP, 9 CHR, 6 Polycliniques
Mise en œuvre des standards d'amélioration de la qualité des soins maternels et néonatals,	3,23 %
Disponibilité de protocoles et de procédures à jour	46,67 %
Traçabilité adéquate des soins	46,67 %

Situation de la qualité des soins et services en SMI

❑Qualité des SPN (N=147)

Items	147 FS (6 CHU, 3 HP, 9 CHR, 6 Polycliniques, 47 CMA et 76 cliniques/CMC)
Disponibilité du personnel qualifié pour des SPN de qualité	86,67%
Disponibilité de protocoles et de procédures à jour pour des SPN de qualité	**25% privé v 78,69% public**
Disponibilité de médicaments et consommables pour les SPN	49,16% dont 36,71% privév52,6% public

Situation de la qualité des soins et services en SMI

❑Qualité de la PEC de l'accouchement (N=147)

Items	147 FS (6 CHU, 3 HP, 9 CHR, 6 Polycliniques, 47 CMA et 76 cliniques/CMC)
Surveillance du travail d'accouchement à travers le partogramme/GGTA	**33,33% privés v 58,33% publics**
Administration immédiate de l'ocytocine pour la GATPA	**76,19% dont 20% des polycliniques**
Disponibilité des médicaments et consommables pour la PEC de l'accouchement	54,17%

Situation de la qualité des soins et services en SMI

❑Qualité de la PEC de l'accouchement (N=147)

Items	147 FS (6 CHU, 3 HP, 9 CHR, 6 Polycliniques, 47 CMA et 76 cliniques/CMC)
PEC de la douleur et soins humanisés des parturientes	50% CHU/HP 46,66% CHR/Polycliniques **34,70% CMA/CMC**
Respect de la dignité de la parturiente	62,5% CHU/HP 70% CHR/Polycliniques **34,70% CMA/CMC**
Parturiente victime de violence verbale	25% CHU/HP **46,66% CHR/Polycliniques** 18,37% CMA/CMC

Situation de la qualité des soins et services en SMI

❑Qualité de la PEC immédiate du NNE (N =147)

Items	147 FS (6 CHU, 3 HP, 9 CHR, 6 Polycliniques, 47 CMA et 76 cliniques/CMC)
Examen clinique complet du NN à sa sortie	73,59% des structures
Information des mères sur les signes de danger	**33,33% des hôpitaux privés**
Mise au sein précoce	71,39%

Situation de la qualité des soins et services en SMI

❑Qualité de la PF(N =147)

Items	147 FS (6 CHU, 3 HP, 9 CHR, 6 Polycliniques, 47 CMA et 76 cliniques/CMC)
Intégration de l'offre de la planification familiale dans la prise en charge des cibles	**50,76 %** des structures
Satisfaction des clientes	**8,44 %**

Outils et bonnes pratiques de renforcement de la qualité des soins et services en SMI

- Standards et chartes pour l'amélioration de la qualité des soins maternels, néonatals du MS recommandant la **bientraitance de la mère et de l'enfant ainsi que le respect de leurs droits;**
- Référentiels qualité du Ministère de la Santé;
- Evaluation des pratiques professionnelles en santé.

Défis

- Insuffisance en ressources humaines qualifiées;
- Faible appropriation des référentiels par les prestataires;
- Insuffisance dans le financement.

Recommandations/perspectives

- A l'endroit des décideurs du ministère de la santé

Renforcer la collaboration avec les **ordres professionnels** pour une meilleure intégration des questions d'éthique et de qualité dans la délivrance des soins.

- A l'endroit des prestataires de services

- S'approprier les **référentiels** d'amélioration de la qualité des soins du MS;
- Organiser et mettre en œuvre des **programmes d'EPP** dans les ES

CONCLUSION

Présent panel = opportunité d'échanges sur les **défis à relever** en vue de l'amélioration de la qualité des soins maternels, néonatals et infantiles dans la région des Hauts Bassins et partant dans le pays tout entier.

CONCLUSION

« Celui qui dit que la qualité est chère, c'est qu'il n'a pas encore évalué le cout de la non-qualité ».

Joseph JURAN

Direction de la qualité des soins
et de la sécurité des patients

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Bobo Dioulasso, Juillet 2025